Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Seit wann haben Sie Atemnot?
Ist die Atemnot plötzlich oder langsam aufgetreten?
Besteht die Atemnot nur bei Belastung oder auch in Ruhe?
Ist sie dauerhaft vorhanden oder kommt sie in Attacken?
Wie lange dauert eine Attacke?

Haben Sie Husten?
Treten Husten und Atemnot gleichzeitig auf?
Seit wann haben Sie Husten?
Kommt der Husten in Attacken?
Haben Sie auch nachts Husten?
Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Auswurf?
Gibt es Blut im Auswurf?

Haben Sie Brustschmerzen, ein Engegefühl in der Brust oder Herzklopfen?
Haben Sie Fieber?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
Wie viele Attacken haben Sie pro Woche?
Verschlechtern sich die Symptome in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden?

Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden, z. B. kaltes Wetter oder haben Sie sich verschluckt?

Haben Sie während der Attacken pfeifende Atemgeräusche bemerkt?
Sind Ihnen Giemen oder Brummen aufgefallen?

Können Sie flach liegen oder brauchen Sie zum Schlafen mehrere Kissen – besonders nach einer Attacke?
Ist Ihre Brust während der Attacke angeschwollen?

Haben Sie geschwollene gerötete überwarmte Beine bemerkt?
Haben Sie Schwindel?

Haben Sie geschwollene Bein bemerkt?

Haben sie Sodbrenen, saureß Aufstoßen?

Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zu einer Katze oder anderen Tieren?
Kann es einen Zusammenhang zwischen Ihrem Labrador und Ihren Beschwerden geben?

Arbeiten Sie im Büro oder zu Hause?
Treten Ihre Beschwerden zu Hause, bei der Arbeit oder an beiden Orten auf?

AUFKLÄRUNG

Ich habe einen Verdacht auf **Asthma** (wie Ihre Mutter), und vielleicht aufgrund Ihres neuen Hunds. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, um Ihre Lunge zu hören, dann Ihnen ein wenig Blut abnehmen. Wir werden danach einen LuFu, und ein Prick-Hauttest durchführen. Anschließend werden wir einen Lungen-Röntgen machen.
Haben Sie noch Fragen?

Spirometrie (LUFU):

Die Spirometrie ist ein Lungenfunktionstest, bei dem Sie in ein Gerät atmen, um die Kapazität und Funktion Ihrer Lungen zu messen.
Ihre Nase wird mit einer Nasenklemme verschlossen.Sie atmen tief ein und dann kräftig wie möglich in ein Mundstück aus, das an ein Gerät angeschlossen ist.
Dann werden die Befunde auf einem Bildschirm dargestellt.
Das Verfahren tut nicht weh und dauert nur ein paar Minuten.

Rö:

Es ist eine schmerzfreie Untersuchung des Brustkorbs mit Röntgenstrahlung. Die Röntgenbelastung hier ist sehr gering so machen Sie sich keine Sorgen.
Bei der Untersuchung müssen Sie für einige Zeit still und ganz ruhig vor dem Röntgengerät stehen.
Vor der Untersuchung müssen Sie Ihre Kleidung sowie Schmuck ablegen (Kugelschreiber, Brille, Gürtel, Schlüsselbund, Ohrringe, Haarnadeln).
Mit dieser Untersuchung können wir viele Sachen beurteilen (Lungen, Herzgröße, Zwerchfell) (Knochenbrüche) (Freie Luft im Bauchraum, Darmverschluss)

Vorstellung:

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen.

Bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Es geht um Herrn Poople Bach. Er ist 55 Jahre alt, geboren am 08.04.1973. Er ist 1,81 m groß und wiegt 74,4 kg.

Herr Bach stellt sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretener Dyspnoe und trockenem Husten vor.
Laut Angaben des Patienten sind die Symptome plötzlich und attackenartig aufgetreten und dauern jeweils 10–15 Minuten.
Er berichtet, dass die Symptome belastungsunabhängig sind und spontan wieder verschwinden.

Er gab keinen klaren Auslöser an. Allerdings hat er kurz vor Beginn der Beschwerden einen Labrador für seine Frau gekauft. Bei der Allergieanamnese ergab sich eine Allergie gegen Katzenhaare in der Kindheit.
Außerdem klagt er seit drei Wochen über ähnliche Beschwerden. Die Symptome verschlimmern sich nachts und in den frühen Morgenstunden, während sie sich bei der Arbeit oder an der frischen Luft bessern.

Vegetativ-anamnestisch war alles unauffällig bis auf nächtliche Attacken.

Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte er Bauchschmerzen und Diarrhö bei Stress (Verdacht auf RDS) sowie einen Zustand nach Hepatitis A.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Kijimea bei Bedarf.

Bei der Noxenanamnese erwähnte er lediglich ein bis zwei Gläser Rotwein pro Woche.

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater (vor einem Jahr daran verstorben), Asthma bei der Mutter und einen Verdacht auf Nierenversagen beim Bruder, der dialysepflichtig ist.

Sozialanamnestisch ist er im IT-Bereich tätig, verheiratet und hat keine Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein **allergisches Asthma** hin.
Paroxysmale Dyspnoe, trockener Husten, eine Allergie gegen Katzenhaare in der Kindheit und das Auftreten der Beschwerden nach Anschaffung eines Labradors sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen GERD, ACS und ein Bronchialkarzinom in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen.
Bei der Inspektion suche ich nach einem Fassthorax, bei der Auskultation nach pfeifenden Atemgeräuschen.
Anschließend werde ich die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.

Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Gesamt-IgE im Serum, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Herzenzymparemeter, Elektrolyte sowie Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen.

Anschließend werde ich eine Spirometrie mit Reversibilitätstest, einen Prick-Hauttest und eine Röntgen-Thorax-Aufnahme durchführen und ein Konsil bei der Abteilung für Pulmonologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Der Patient wird ambulant behandelt.
Allergenkarenz wird empfohlen.
Er sollte zu Beginn niedrig dosierte inhalative Kortikosteroide (z. B. Fluticason) als Dauermedikation sowie ein kurzwirksames β2-Sympathomimetikum (Salbutamol) als Bedarfsmedikation erhalten.
Wenn dies nicht ausreicht, können wir ein langwirksames β2-Sympathomimetikum (Salmeterol) in Kombination mit ICS hinzufügen.

🌬️ Asthma bronchiale – 4 diagnostische Kriterien

1 Typische Symptome

- Anfallsartige Atemnot
- Giemen (pfeifende Atmung)
- Husten, v.a. nachts / früh morgens
- Engegefühl in der Brust

---

2 Variable Atemwegsobstruktion

- Nachweis in der Spirometrie
- $FEV_1/FVC \downarrow$ **(„Der FEV-eins-zu-FVC-Quotient ist erniedrigt.“)**
- Reversibilität nach Bronchodilatator ($FEV_1 \uparrow \geq 12$ % und ≥ 200 ml)

---

3 Variabilität der Symptome

- Schwankend im Verlauf
- Besser unter Therapie, schlechter bei Triggern (Allergen, Infekt, Belastung)

---

4 Ausschluss anderer Ursachen

- COPD, Herzinsuffizienz, Infekt, Tumor ausgeschlossen

🎯 Kısa Almanca özet:

Die Asthmadiagnose basiert auf typischen Symptomen, einer variablen und reversiblen Atemwegsobstruktion, der Variabilität der Beschwerden und dem Ausschluss anderer Erkrankungen.

🌬️ Asthma – semptomlara göre şiddet sınıflaması (Almanca)

Leicht intermittierend

- Tagsüber: $\leq 2\times$ pro Woche
- Nachts: $\leq 2\times$ pro Monat
- Lungenfunktion normal zwischen Anfällen

Leicht persistierend

- Tagsüber: > 2× pro Woche, aber nicht täglich
- Nachts: 3–4× pro Monat

Mittelgradig persistierend

- Tagsüber: täglich
- Nachts: ≥ 1× pro Woche

Schwer persistierend

- Tagsüber: kontinuierlich
- Nachts: häufig (mehrmals pro Woche oder jede Nacht)

🎯 Kısa özet tablo

Schweregrad	Tagsüber	Nachts
Intermittierend	selten	selten
Leicht persistierend	öfter	3–4×/Monat
Mittel persistierend	täglich	≥1×/Woche
Schwer	ständig	sehr häufig

DE Tek cümlelik özet:

„Die Asthmaschwere wird anhand der Häufigkeit der Tages- und Nachtsymptome in intermittierend, leicht, mittelgradig und schwer persistierend eingeteilt.“

Asthma Bronchiale

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Popple Bach\ Nils Nilson\ Matthäus Ladda
Alter: 55 J. (geb. am 08.04.1973)
Größe: 1,81 m
Gewicht: 74,3 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Dyspnoe und trockener Husten seit heute Morgen
- Plötzlich in Ruhe aufgetreten, Progredient, Meistens Morgens \Abends
- Attackenartig (4 Attacken\ jede Attacke dauert 10- 15 Min).
- Auslöser: Keine.
- Lindernde Faktoren: Keine
- Verstärkende Faktoren: Keine
- Ähnliche Beschwerden: seit 3 Wochen aber leichter 10 min. dauert

V/A:

Unauffällig bis auf nächtliche Attacken

V/E:

Diarrhö und abdominale Schmerzen bei Stress (V. a. RDS)
Ikterus während einer Reise nach Brasilien vor 10 J. (V. a. Hepatitis A)

M:

Kijimea b.B. gegen RDS

Vor-op:

TE mit 7. LJ
Appendektomie (AEE mit 15 .LJ)

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Katzenhaarallergie in der Kindheit

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 1-2 Gl.Rotwein/W.
- Drogenkonsum: wurde verneint

- **Sozialanamnese:**

Informatiker (Tätig im IT-Bereich)
Verheiratet
keine Kinder
Hundebesitzer seit 3 W

- **Familienanamnese:**

Vater: verst. an Bronchialkarzinom, mit 60 LJ.
Mutter: Asthma

Bruder: Dialysepflichtig

- **Verdachtsdiagnose:**
  Asthma Bronchiale (Allergisches Asthma)

- **Differentialdiagnose**
  Pneumonie
  COPD
  Bronchialkarzinom
  GERD

- **weitere Diagnostik**
- KU EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - BGA
- Spirometrie
- Peak-Flow-Messung
- Röntgen-Thorax
- Ggf. CT-Thorax
- Pneumologisches Konsil.

- **Therapievorschläge**
- Ambulante Behandlung
- Allergenkarenz
- Stufentherapie
- Inhalative Kortikosteroide (ICS)
- Kurzwirksame Beta-2 Agonisten (SABA)
- Ggf. Montelukast

(1)

- Schmerzwanderung in den rechten Unterbauch
- Appetitlosigkeit
- Übelkeit und Erbrechen
- Schmerzen im rechten Unterbauch *(2 Punkte)*
- Loslassschmerzen
- Fieber (ab 37,3°C)
- Leukozytose über 10.000/µl *(2 Punkte)*
- Linksverschiebung im Differentialblutbild
- ⇨ > 7 Punkte: 93% Wahrscheinlichkeit

Akuta momentan Luftnot vor diyorsu —) Können Sie jetzt gut Luft kriegen?

Brauchen Sie Hilfe?

Ich kann Ihnen Sauerstoff geben

21. Asthma bronchiale s.25

Arzt-Patient-Gespräch

Der Patient und die Prüferin waren nett und sprachen deutlich und langsam genug, um Notizen machen zu können

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Popple Bach
- 55J.
- *08.04.1973
- 1,81 m
- 74,4 kg

-Hauptbeschwerde

- Dyspnö (Luftnot)
- Trockener Huster (Reizhusten)
  - Seit heute Morgen
  - Attacken dauern 10-15 Minuten
  - Nicht belastungsabhängig, gehen von selbst weg
  - Leichte ähnliche Beschwerden seit 3 Wochen
  - Jetzt beschwerdefrei

- Wie viele Anfälle haben Sie pro Woche? Wie viele nächtliche Anfälle haben Sie pro Monat?
- Verschlechtern sich die Symptome in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden?
- Sind Ihnen Keuchen (Giemen) oder Brummen aufgefallen?
- Tritt die Atemnot kurz oder dauernd auf? Tagsüber oder nachts? In Ruhe oder unter Belastung?
- Bekommen Sie Atemnot, wenn Sich flach liegen? Schlaffen Sie mit erhöhtem Oberkörper?
- Haben Sie Brustschmerzen? Engegefühl in der Brust? Herzklopfen?
- Ist der Husten eher trocken oder mit Auswurf? Wie sah es aus? Welche Farbe und Konsistenz har der Auswurf? Gibt es Blut?
- Haben Sie geschwollene Beine? Schwindel?
- Haben Sie etwas verschluckt?
- Haben Sie Probleme in Bezug auf Ihre Nase? Nasenbluten, Heuschnupfen, eine Verletzung?

-vegetative Symptomatik

kein

-Vorerkrankungen

Reizdarm Syndrome –

②

- RDS: wenn ich Stress habe, bekomme ich Magen Schmerzen und Durchfall
- Virale Hepatitis A vor 10 J. ich hatte Gelbsucht vor ein paar Tage in Brazil, jede bekommt Gelbsucht dort
  - Es gibt eine Impfung gegen Hepatitis A, die Sie vor der Reise machen können. Ich empfehle sie Ihnen, wenn Sie wieder in die Tropen reisen.

Einige Krankheiten trickern in manchen Regionen häufiger auf,

-Vor-OPs

- TE mit 7. LJ
- AE mit 20 LJ

Ist es heilbar?

Ja, Asthma ist eine behandelbare Krankheit.

-Medikation

- Kijimea (Probiotika) b.B gegen RDS

-Allergien

- Katzenhaare Allergie: ich hatte in der Kindheit Katzenkratzer

-Noxen

Hilfe! Künstliche Befruchtung usw.?

- Alkoholkonsum: 1-2 Gläser Rotwein pro Woche

Ja, natürlich, ich hoffe, Sie können auch ein Baby haben. Manche Leute versuchen diese Therapie viele Male und bekommen dann ein Kind. Wir sollen immer positiv denken

-Sozialanamnese

- Tätig im IT-Bereich
  - Haben Sie auf der Arbeit mit belastenden Dämpfen oder Stäuben zu tun?
- Verheiratet
- keine Kinder: ich möchte Kinder aber ich kann nicht kriegen. Ich plane eine In-Vitro-Fertilisation (IVF) – Künstliche Befruchtung – in DL deswegen habe ich vor 3 Wochen einen Labrador für meine Frau gekauft. Ich verstehe, das ist eine schwierige Situation
  - Haben Sie Tiere?

Almanzo 20

Eine IVF kann eine wichtiger Schritt sein, und es ist gut, dass Sie sich bereits damit beschäftigen.

-Familienanamnese

- Vater (75 J.) t an Bronchialkarzinom letzte Jahr
  - Habe ich auch Krebs? Ich denke nicht, aber wir werden das trotzdem überprüfen mit einem Lungen-Röntgen
- Mutter hat Asthma
- Bruder: Dialyse pflichtig Blutwäsche
  - Was ist Blutwäsche und warum müssten meine Brüder 2 mal pro Woche ins KH gehen?
  - Es handelt sich um ein Gerät, das das Blut Ihres Bruders anstelle seiner Nieren filtert, während er auf eine Transplantation wartet. Es ist gut, dass er richtig behandelt werden kann. Ich hoffe, dass er bald sein Transplantat erhält.
  - Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ihre Angst ist vollständig verständlich. Aber ich gehe nicht davon aus. Ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen.

Blutwäsche, auch Dialyse genannt, ist eine Ersatztherapie bei Nierenversagen. Wahrscheinlich hat Ihr Bruder Nierenversagen

Ich habe einen Verdacht auf **Asthma** (wie Ihre Mutter), und vielleicht aufgrund Ihres neuen Hunds. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, um Ihre Lunge zu hören, dann Ihnen ein wenig Blut abnehmen. Wir werden danach einen LuFu und ein Prick-Hauttest durchführen. Anschließend werden wir einen Lungen-Röntgen machen.

Habe ich Asthma wie meine Mutter? Warum habe ich Asthma. Habe ich Allergie gegen Hund? Gibt es nur allergische Asthma oder?

Haben Sie noch Fragen?

Ja, höchstwahrscheinlich haben Sie allergisches Asthma. Manche allergische Faktoren verursachen Asthma. Ihr Hund könnte die Ursache sein.

Spirometrie (LUFU):

Die Spirometrie ist ein Lungenfunktionstest, bei dem Sie in ein Gerät atmen, um die Kapazität und Funktion Ihrer Lungen zu messen. Ihre Nase wird mit einer Nasenklemme verschlossen.

Ja, es gibt verschiedene Asthma-Typen. Infektionen, Fumle, Stressbelastung, Allergene oder Umweltbedingungen können Asthma verursachen. Aber Ihr Fall passt zu allergischem Asthma

Sie atmen tief ein und dann kräftig wie möglich in ein Mundstück aus, das an ein Gerät angeschlossen ist. Dann werden die Befunde auf einem Bildschirm dargestellt.
Das Verfahren tut nicht weh und dauert nur ein paar Minuten.

Rö:
Es ist eine schmerzfreie Untersuchung des Brustkorbs mit Röntgenstrahlung. Die Röntgenbelastung hier ist sehr gering so machen Sie sich keine Sorgen.
Bei der Untersuchung müssen Sie für einige Zeit still und ganz ruhig vor dem Röntgengerät stehen.
Vor der Untersuchung müssen Sie Ihre Kleidung sowie Schmuck ablegen (Kugelschreiber, Brille, Gürtel, Schlüsselbund, Ohrringe, Haarnadeln).
Mit dieser Untersuchung können wir viele Sachen beurteilen (Lungen, Herzgröße, Zwerchfell) (Knochenbrüche) (Freie Luft im Bauchraum, Darmverschluss)

Anihostoyun atoizlar halinde Dyspnoe

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Popple Bach, 55** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt seine aktuellen Symptome wie folgt: heute Morgen rezidivierende und paroxysmale Dyspnoe und Trockener Husten. Eine Attacke dauert circa 15 Minuten und hört von selbst auf. Leichte ähnliche Beschwerden seit 3 Wochen.

Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.

Er hat seit ? Colon Irritabile und nimmt gelegentlich dagegen Kijima (Probiotikum) ein.

Der Patient ist seit seiner Kindheit gegen Katzenhaare allergisch.

Die Sozialanamnese zeigt, dass der Patient seit drei Wochen einen Hund hat (als die Symptome begannen).

In der Familienanamnese gibt es Bronchialkarzinom und Asthma.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Asthma bronchiale. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Laryngitis, COPD (*Chronic Obstructive Pulmonary Disease*) Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, GERD, Sarkoïdose.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen (Inspektion: Fassthorax, Auskultation: Giemen, pfeifende Atemgeräusche); dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, BSG, Leber-Nierenwerte, E-lyte, und Gesamt IgE im Serum.

Anschließend ist ein EKG, eine Spirometrie mit Reversibilitätstest, Prick-Hauttest und einen Röntgen-Thorax. Weiterführend ist ein pneumologische Konsil anzufordern.

Ich werde ihm ambulant behandeln.

Bei gesicherter Verdachtsdiagnose empfehle ich am Anfang eine niedrigdosierte inhalative Corticosteroide (Fluticasone) als Dauermedikation und eine kurzwirksame B2 Sympathomimetika (Salbutamol) als Bedarfmedikation für akute Phase.
Wenn das nicht reicht können wir in Kombination mit ICS eine langwirksame B2 Sympathomimetika (Salmeterol) hinzufügen.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

- pseudoallergische Reaktion (Analgetikaintoleranz), zB gegen ASS (NSAR); häufig neben Asthma auch Polyposis / nasi und Rhinopathie → Samter-Trias.
- Refluxkrankheit.
- somatische oder psychische Anstrengung.
- Tabakrauch.
- Ozon oder Nitrosegase.
- kalte Luft oder Nebel.

Pathogenese: Allergen + bronchiale Hyperaktivität ❑ Schleimhautödeme + Bronchospasmen ❑ endobronchialen Obstruktion (❑ strukturellen Veränderung der Bronchialwände mit Fibrosierung)

Symptome:

- Dyspnoe mit exspiratorischem Stridor
- Ausgeprägter Hustenreiz
- Tachykardie

Diagnostik:

- **KU**
  - Inspektion: Fassthorax, Zyanose
    - Bei schwerer Atemnot (Kindesalter ++): thorakale Einziehungen (interkostalräume, epigastrisch)
  - Perkussion: hypersonorer Klopfschall
  - Auskultation: Giemen, Brummen, Pfeifen, verlängertes Exspirium
    - Bei schwerer Obstruktion ist das Atemgeräusch sehr leise
- **Labor**: gr.BB, Ig, CRP, BSG
- **Spirometrie**
  - FEV1 ↘ und FVC normal
  - Tiffeneau-Index (FEV1/FVC) < 70%
  - Positive Reversibilitätstest mit SABA: nach 15min FEV1 ↗ + von 12% und 200ml
- **Allergiediagnostik**
  - Prick-Hauttest
  - Gesamten und/oder spezifischen IgE
- **Röntgen-Thorax**

Therapie ❑ Stufentherapie:

- Stufe I: SABA b.B. + niedrig dosierte ICS
- Stufe II: niedrig bis mittelhoch dosierte ICS, oder Montelukast (LTRA), Theophyllin
- Stufe III: mittelhoch dosierte ICS + LABA als Dauermedikation; oder Montelukast (LTRA), Theophyllin.
- Stufe IV: ICS / LABA-Kombination + Tiotropium (Anticholinergikum); oder hoch dosiertes ICS ± LABA ± Tiotropium ± Montelukast.
- Stufe V:
  - bei allergischem Asthma ❑ Omalizumab (anti-IgE)
  - bei eosinophilem Asthma ❑ Mepolizumab (anti-IL-5)
  - ggf. ergänzend Glukokortikoide oral als Dauermedikation

⇨ **Für jede Therapiestufe** ist der Einsatz eines **SABA** als **Bedarfsmedikament** möglich, um akut auftretende Symptome zu behandeln.

Folgende Medikamente werden derzeit eingesetzt:

- SABA (kurzwirksame β2-Sympathomimetika): z.B. Salbutamol, Fenoterol, Terbutalin
- LABA (langwirksame β2-Sympathomimetika): z.B. Formoterol, Salmeterol
- LAMA (langwirksame Muskarinrezeptor-Antagonisten): Tiotropiumbromid
- ICS (inhalative Glukokortikoide): z.B. Budesonid, Fluticason, Beclometason, Ciclesonid, Mometason
- orale Glukokortikoide: Prednisolon

- LTRA (Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten): Montelukast
- Biologika / Anti-IgE-Antikörper: Omalizumab

Asthmaanfall

Bilinç bozukluğu dispnezle

Symptome: veränderte Bewusstseinsebene, Arrhythmie, Zyanose, Fatigue / Erschöpfung, Hypotonie, Hypoxie, Tiffeneau-Index < 33%

Therapie:

- Den Patienten beruhigen, sitzende Körperhaltung
- O2: 2-4 L/min
- SABA: 2-4 Hübe inhaler spreyle sizma sayısı
- Prednisolon 50-100mg **iv**
- *Ggf. Theophyllin 200 mg* ***iv***
- *Ggf. Magnesiumsulfat* ***iv***

22. Pneumonie (neuer Fall)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Jens Bergner / Niko Kroos / Tim Jelscht *(jungen blonden Mann, deutlich, laut)*
- 38 J.
- *08.04.1986
- 1,73m
- 80kg

-Hauptbeschwerde

- Bestehende Husten Haben Sie Luftnot? Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
  - seit 6 Tagen
  - mit gelblichem und grünem Auswurf, ohne Blut
- Schmerzen im Hals Können Sie diese Schmerzen beschreiben?
  - seit 6 Tagen
- Brustschmerzen Haben Sie Brustschmerzen im Zusammenhang? Herzklopfen? Herzrasen?
  - seit 3 Tagen
  - langsam aufgetreten
  - persistierend
  - progredient
  - ziehend und stechend
  - ohne Ausstrahlung
  - Linderungsfaktor: sitzen und stehen
  - Verschlimmerungsfaktor: liegen
  - NRS: 6/10
- Dyspnö Tritt diese Luftnot bei Bewegung oder auch in Ruhe auf? Ist es schlimmer, wenn Sie sich hinlegen?
  - seit 3 Tagen
  - Bewegungs<u>un</u>abhängig
- Gab es in letzter Zeit jemanden in Ihrer Umgebung, der krank war?
  - Meine Tochter hatte vor einer Woche ähnliche Beschwerden, aber jetzt ist sie gesund.
  - Hat sie bei ihrem Arzt eine Diagnose erhalten? Bronchitis

-vegetative Symptomatik

Spirometrie mit Reversibilitätstest

zuerst wird normal Spirometrie durchgeführt.

Danach bekommt ~~der~~ Patient ein kurzwirksames Bronchodilatator (Salbutamol).

Dann ~~ein~~ wartet er ca 15-20 Minuten.

Die Spirometrie wird einmal durchgeführt.

Der Reversibilitätstest zeigt, ob sich eine bronchiale Obstruktion nach Gabe eines Bronchodilatators verbessert. Das spricht für Asthma.

nach Gabe eines Bronchodilatators → ≥12% ≥200 ml FEV1

Forciertes Exspiratorisches Volumen in 1 Sekunde

FEV1 misst das ausgeatmete Volumen in der ersten Sekunde, FVC das gesamte forcierte Ausatemvolumen. Der FEV1/FVC-Quotient (Volumen) zeigt, ob eine Obstruktion vorliegt

Sozialanamnese

- in IT Bereich tätig (manchmal zu House, manchmal im Büro)
- verheiratet - lebt mit seiner Frau
- keine Kinder, Kinderwunsch, IVF planen,
- Stress im Privatleben
- vor 3 Wochen einen Labrador adoptiert

Verdachtsdiagnose

- allergisches Asthma

Differentialdiagnose

- COPD
- Bronchialkarzinom
- GERD

Weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter (CRP), Gesamt IgE, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte in Serum, BGA
- Spirometrie → Reversibilitätstest
- Prick-Hauttest → Prick-Test
- Röntgen-Thorax
- ~~ggf. ein Konsil in Pulmonologie~~

Therapie

- ambulante Behandlung
- Allergenkarenz
- ggf. Sauerstoffgabe 2-4 l/min ≤ 92 % (wenn SpO_2 < 92 %)
- Stufentherapie
  - ICS als Dauertherapie SABA als Bedarfstherapie
  - ggf. Montelukast Theophylin
  - ggf. LABA + LAMA + Tiotropiumbromid + Omalizumab
- ggf. pulmonologisches Konsil

Bei der Auskultation achte ich darauf dass die Pfeifgeräusche, Brummen, Giemen vorhanden sind.
fasstthorax →
→ 1. inhalative Kortikosteroid, Salbutamol bei der Attacke → 2/4 lt Sauerstoff -

Stufe 2 → Salbutamol, inhalativ steroid, B2 Sympathomimetik.
→ Montelukast → Leukotrien hemmer -

→ Spirometrie ist ein Lungenfunktion test. Bei der Spirometrie messen wir, wie viel und wie schnell Sie Luft ausatmen können.
Sie atmen tief ein, dann kräftig durch den mundstück aus. So sehen wir, ob Ihre Atemwege verengt sind.

Asthma → chronische entzündliche Atemwege, durch die Bronchialhyperaktivität, variable Atemwegsobstruktionen.
- Extrinsisch → Allergisch / nachweisbare E

Asthmaanfall: veränderte Bewusstsemebrane, Arythmie, Cyanose, Fatigue, Erschöpfung, Hypertonie → Hypoxie. Tiffeneau index -

Therapie: Sitzende, beruhigende Körperhaltung - O2 2/4 L/min
SABA → 2-4 Züge → Kesa Etkili
Prednisolon 50-100 g IV,
Theophyllin // Magnesiumsulfat.
ggf. LABA → Uzun etkili
(Kurzwirksam / Langwirksam)